



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN I
SUB ETIK & DISIPLIN
KOMITE KEPERAWATAN
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

I. SDM

1.1 Ketenagaan (Kebutuhan dan Distribusi Tenaga, Kualifikasi Tenaga).

Jumlah anggota Sub Komite Etik & Disiplin Keperawatan: 2 orang

Ketua : Sherly Rosita, S. Kep. Ns (S1 Keperawatan)

Anggota : Amilatul Khilifah, A.Md. Kep (D3 Keperawatan)

1.2 Orientasi

- Orientasi: Dilakukan sosialisasi dan pengisian logbook etik staf perawat baru sebanyak 5 orang terhitung mulai 2 Februari 2026.

1.3 Pendidikan dan Pelatihan

- Tidak dilakukan kegiatan pelatihan.

1.4 Evaluasi Kinerja Staf

- Evaluasi kepatuhan terhadap etika profesi dan disiplin kerja dilakukan melalui pengamatan/supervisi dan laporan unit.
- Tabel 1.4 Data kedisiplinan kerja staf perawat/bidan triwulan I tahun 2026

Periode Bulan	Jumlah Keterlambatan (orang)	Jumlah Perawat/Bidan	Prosentase Keterlambatan
Januari 2026	46	163	28,22%
Februari 2026	47	163	28,83%
Maret 2026	30	163	18,40%

Analisa:

Berdasarkan data keterlambatan kerja staf perawat/bidan selama Triwulan I Tahun 2026, terjadi penurunan jumlah keterlambatan dari bulan Januari sebanyak 46 orang (28,22%) menjadi 30 orang (18,40%) pada bulan Maret, dan sedikit meningkat pada Februari sebanyak 47 orang (28,83%).

Secara keseluruhan, kedisiplinan kerja perawat/bidan pada triwulan I tahun 2026 belum stabil, dengan tingkat keterlambatan tertinggi pada Januari dan terendah pada Maret. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi disiplin kerja.

Namun jika dilihat dari jumlah keterlambatan per masing-masing orang, rata-rata 21,27% hanya terlambat 1-3 kali dalam 1 bulan, 3,48% sisanya terlambat 4-7 kali, tidak ada yang melebihi terlambat >7 kali.

Faktor penyebab yang diidentifikasi antara lain:

- Faktor individu: Kurangnya kesadaran dan komitmen individu terhadap kedisiplinan waktu. Masalah pribadi atau keluarga yang mempengaruhi kesiapan hadir tepat waktu.
- Faktor lingkungan kerja: Kondisi lalu lintas, cuaca, atau jarak tempat tinggal ke tempat kerja. Pada triwulan ini, kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas puasa dan lebaran serta peningkatan kebutuhan pribadi.
- Faktor sistem: Jadwal kerja shift malam atau pergantian shift yang padat dapat menyebabkan kelelahan fisik, sehingga berdampak pada ketepatan waktu masuk kerja.
- Faktor motivasi: belum adanya sistem penghargaan atau sanksi yang diterapkan secara tegas.

Rencana tindak lanjut:

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan disiplin waktu kerja perawat/bidan	Seluruh perawat dan bidan	Monitoring kehadiran melalui absensi harian dan rekap bulanan keterlambatan	Kepala Ruangan, SDM Keperawatan	Setiap hari / Bulanan
Menurunkan angka keterlambatan	Perawat/bidan yang sering terlambat	Sosialisasi ulang kebijakan jam kerja dan SPO kedisiplinan	Kepala Ruangan	Minggu ke-1 bulan berjalan
Meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja	Seluruh perawat dan bidan	Penegasan aturan disiplin dan batas toleransi keterlambatan	Manajer Keperawatan	Setiap bulan
Memberikan motivasi kerja	Perawat/bidan dengan kehadiran terbaik	Pemberian reward/apresiasi kehadiran terbaik	Manajemen Keperawatan	Setiap triwulan
Mengurangi keterlambatan akibat kelelahan kerja	Perawat/bidan shift	Evaluasi dan penyesuaian jadwal shift serta beban kerja	Kepala Ruangan, Penjadwal	Setiap bulan
Mengatasi keterlambatan berulang	Perawat/bidan yang terlambat ≥3 kali	Pembinaan individu dan konseling	Kepala Ruangan	Sesuai kebutuhan
Mencapai target penurunan keterlambatan ≤10%	Seluruh perawat dan bidan	Evaluasi hasil RTL dan tindak lanjut perbaikan	Tim Mutu, Manajer Keperawatan	Setiap triwulan

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

- Penggunaan form laporan pelanggaran etik dan disiplin melalui form elektronik sudah berjalan.

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

3.1 Jumlah penanganan kasus Etik Keperawatan yang ditangani.

Tabel 3.1 Data penanganan kasus Etik Keperawatan triwulan I tahun 2026.

Tanggal	Jenis Pelanggaran	Unit	Kategori Pelanggaran Kasus	Jumlah Kasus	Bentuk Pembinaan/Teguran	Hasil Pembinaan	Tindak Lanjut	Petugas Pembina	Status
23/01/2026	Kejadian komplek DPJP terkait sikap perawat yang dianggap menyalahi/mendahului wewenang DPJP, karena konsul ke DPJP lain tanpa persetujuan DPJP awal.	IRNA 7A	Pelanggaran ringan dengan objek tanggung jawab perawat terhadap profesi lain.	1	- Teguran Lisan	Perawat meminta maaf terhadap DPJP, perawat memahami kesalahan yang memang sudah menyalahi wewenang dan berkomitmen tidak mengulangi. Perawat juga menyampaikan pada anggota unitnya terkait alur pindah pasien dan proses konsul.	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kabid Pelayanan Medis	Selesai
25/01/2026	Kejadian komplain keluarga pasien terkait sikap perawat yang dianggap kurang menjaga ketenangan dengan berbicara keras saat jam operan.	IRNA 2C	Pelanggaran ringan dengan objek tanggung jawab perawat terhadap pasien.	1	- Teguran Lisan	Perwakilan perawat unit sudah meminta maaf pada penunggu pasien. Petugas terkait sudah paham kesalahannya seharusnya jika memang masih	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IRNA 2C	Selesai

						ada operan yang dirasa kurang harus disampaikan langsung saat di nurse station.			
26/01/2026	Kejadian komplain pasien terkait perawat yang kurang ramah dan tidak komunikatif saat merawat pasien.	IGD	Pelanggaran ringan dengan objek tanggung jawab perawat terhadap pasien.	1	- Teguran Lisan	Petugas paham kesalahannya dan akan memperbaiki cara komunikasi kepada pasien dan tidak mengulangnya lagi.	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IGD	Selesai
28/01/2026	Kejadian komplain DPJP, karena perawat yang tidak melaporkan advice yang sudah diberikan dengan risiko keterlambatan penanganan & risiko penundaan tindakan operasi.	IRNA 4A	Pelanggaran Disiplin Keperawatan dengan objek standar pelayanan	1	- Teguran Lisan	Perawat meminta maaf kepada DPJP terkait. Perawat paham kesalahannya dan tidak mengulangi lagi.	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IRNA 4A	Selesai
05/02/2026	Kejadian komplain pasien terkait perawat yang dianggap tidak menjalankan advis pengobatan dari dokter dan tidak memberikan edukasi saat memberikan terapi obat pada pasien.	IRNA 3C	Pelanggaran ringan dengan objek tanggung jawab perawat terhadap pasien.	1	- Teguran Lisan	Perawat memahami kesalahan yang dilakukan dan memahami bimbingan yang telah diberikan. Perawat bersedia melakukan perbaikan dalam komunikasi	Monitoring perilaku dan komunikasi petugas oleh kepala ruang dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IRNA 3C	Selesai

						terapeutik, pemberian KIE, serta dokumentasi di e-RM.			
16/02/2026	Laporan keluhan dari dokter umum terhadap perawat jaga saat terjadi code blue pada pasien di ruangan yang terjadi perbedaan persepsi dan komunikasi antara tenaga kesehatan.	IRNA 4A	Ringan (Kesalahpahaman antar staf)	1	- Klarifikasi - Mediasi	Permasalahan disepakati akibat perbedaan persepsi dan komunikasi dalam situasi kegawatdaruratan. Perawat telah menyampaikan permintaan maaf pada dokter dan permintaan maaf diterima. Dokter sudah menjelaskan bahwa maksud tindakannya adalah untuk melindungi rekan nakes dari potensi komplain. Kedua pihak sepakat untuk menjaga komunikasi efektif, melakukan klarifikasi tindakan dengan tetap menjaga komunikasi	Monitoring perilaku dan komunikasi antar perawat dan dokter. Perbaikan sistem pelayanan code bluedan orientasi staf perawat baru dikoordinasikan dengan sub mutu dan kredensial keperawatan.	Sub Komite Etik Keperawatan Kabid Pelayanan Medis Sub Komite Etik Medis Sub mutu keperawatan Sub kredensial keperawatan	Selesai

						terutama didepan keluarga pasien dan diskusi lebih lanjut setelah tindakan. saling menjaga sikap profesional dan hubungan kerja yang kondusif. tidak ditemukan pelanggaran etik keperawatan (lebih ke perbedaan persepsi)			
09/03/2026	Kejadian komplain DPJP (IPD) karena perawat yang menggunakan billing untuk mengeluarkan surat istirahat tanpa prosedur pemeriksaan meskipun pada kerabat sejawat sendiri.	IRJA	Pelanggaran Etik ringan dengan objek tanggung jawab perawat terhadap praktek.	1	- Teguran Lisan	Perawat memahami kesalahan yang dilakukan dan memahami bimbingan yang diberikan. Perawat meminta maaf kepada dokter DPJP bersangkutan dan berkomitmen tidak mengulanginya kembali.	Perawat meminta maaf pada DPJP. Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kabid Pelayanan Medis Kepala Ruang IRJA	Selesai
30/03/2026	Laporan dari petugas PIPP terkait dugaan pelanggaran disiplin perawat saat dinas	IRNA 6A	Pelanggaran Disiplin Keperawatan dengan objek	1	-Teguran Lisan	Perawat memahami kesalahan yang dilakukan dan	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM	Selesai

	malam. (tertidur saat berjaga)		standar pelayanan			memahami bimbingan yang telah diberikan. Perawat berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali. Perawat menyampaikan jika dulu memang lebih parah karena riwayat gangguan kecemasan dan harus mengkonsumsi obat yang membuat kantuk. Namun saat ini sudah mulai lepas obat dan memang kesulitan bangun saat kantuk berat.	koordinasi dengan Karu, PIPP dan perawat unit untuk memantau perilaku petugas saat berdinas terutama malam. Konseling perbaikan perilaku dengan istirahat lebih dulu sebelum jam dinas malam, menyibukkan diri saat dinas supaya menghindari kantuk dan kerja sama dengan perawat jaga lain.	Kabid Pelayanan Medis Kepala Ruang IRNA 6A	
--	--------------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Analisa:

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 8 (delapan) kasus etik keperawatan yang ditangani oleh Sub Komite Etik Keperawatan. Kasus pelanggaran etik keperawatan didominasi oleh pelanggaran ringan terkait komunikasi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap SPO. Kasus terjadi di berbagai unit sehingga bersifat sistemik. Seluruh kasus telah ditindaklanjuti dengan pembinaan dan teguran lisan, namun masih diperlukan penguatan sistem, peningkatan kompetensi komunikasi, serta monitoring berkelanjutan untuk mencegah kejadian berulang.

Rencana Tindak Lanjut:

No	Permasalahan	Analisa Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu
1	Komunikasi tidak efektif dengan pasien/DPJP	Kurangnya pemahaman komunikasi terapeutik & SBAR	Pelatihan komunikasi efektif (SBAR) & edukasi komunikasi terapeutik	Komite Keperawatan, Diklat	Triwulan II
2	Tidak patuh SPO/alur pelayanan (konsul, advis, billing)	Sosialisasi SPO belum optimal	Sosialisasi ulang SPO & supervisi implementasi	Kepala Ruang, Komite	Bulanan
3	Sikap kurang profesional (tidak ramah, suara keras)	Kurangnya awareness perilaku pelayanan	Pembinaan perilaku profesional & budaya pelayanan	Kepala Ruang	Rutin
4	Kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan	Kurang koordinasi tim	Penguatan teamwork & briefing sebelum pelayanan	Komite, Unit	Bulanan
5	Pelanggaran disiplin (tertidur saat dinas)	Faktor kelelahan & individu	Monitoring shift, konseling, pengaturan jadwal	Kepala Ruang, SDM	Rutin
6	Perbedaan persepsi dalam kondisi emergensi	Kurangnya pemahaman peran tim	Simulasi code blue & orientasi staf	Komite, Diklat	Semester
7	Pembinaan masih reaktif	Belum ada sistem pencegahan	Penguatan monitoring & audit perilaku	Komite Keperawatan	Triwulan

3.2 Fasilitas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

3.3.1 Fasilitas Kesehatan

Staf yang mengalami gangguan pada kesehatannya akibat kerja diberikan ijin sakit dan disarankan untuk periksa ke faskes 1 karyawan untuk melakukan pemeriksaan.

3.3.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tabel 3.3.3 Kejadian Keselamatan Kerja (Manajemen Resiko)

No	Jenis Kejadian	Ringkasan
1	Kecelakaan kerja (JKK) 1 orang.	- Terjadi kecelakaan kerja saat perawat pulang kerja sebanyak 1 orang perawat pada 15 Januari 2026 dan sudah ditangani dan bisa rawat jalan.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring perilaku dan komunikasi profesional perawat dilakukan oleh Kepala Ruangan dan Koordinator Shift melalui observasi langsung saat pelayanan. Pemantauan dilakukan terhadap interaksi antar perawat dan antar profesi, khususnya di unit IRNA dan IRJA. Setiap potensi konflik, komplain, atau indikasi pelanggaran etik dicatat dan dilaporkan kepada Sub Komite Etik Keperawatan. Monitoring kepatuhan terhadap kode etik keperawatan dan etika komunikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui briefing unit.

Evaluasi dilakukan oleh Sub Komite Etik Keperawatan setiap triwulan. Indikator evaluasi meliputi:

- Tidak adanya pengulangan kasus etik serupa.
- Menurunnya jumlah komplain terkait komunikasi dan sikap profesional.
- Adanya perubahan sikap dan perilaku positif pada petugas yang telah dibina.
- Hasil evaluasi didokumentasikan dalam laporan komite keperawatan dan menjadi dasar perbaikan program pembinaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penanganan delapan kasus etik keperawatan kategori pelanggaran ringan pada Triwulan I Tahun 2026 yang didominasi oleh masalah komunikasi dan kepatuhan SPO. Evaluasi awal menunjukkan pembinaan efektif secara individu, namun perlu penguatan sistem dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan penurunan kasus pada periode berikutnya. Melalui kegiatan monitoring perilaku, evaluasi berkala, dan edukasi terstruktur, diharapkan tidak terjadi pengulangan kasus serupa, meningkatnya kesadaran etika dan profesionalisme perawat, serta terciptanya lingkungan kerja yang kondusif guna mendukung mutu dan keselamatan pelayanan keperawatan di rumah sakit.

V. PENUTUP

Laporan kinerja Sub Komite Etik dan Disiplin Keperawatan triwulan I tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembinaan etika serta disiplin profesi keperawatan di RS Prima Husada. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan, memperkuat budaya etik dan disiplin di lingkungan rumah sakit, serta memperbaiki sistem pembinaan profesi secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, baik dalam aspek pelaksanaan kegiatan maupun dokumentasi. Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Ketua Komite Keperawatan serta manajemen rumah sakit sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan kegiatan Sub Komite Etik Keperawatan di masa mendatang. Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dilaporkan Kepada,
Ketua Komite Keperawatan



Fariz Tiarawan Fadil C, S. Kep. Ns

Malang, 08 April 2026
Penyusun,
Sub Etik & Disiplin Keperawatan



Sherly Rosita, S. Kep. Ns

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes